

STANDART PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 10 Juni 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur RS. Prima Husada  dr. Nur Mazidah
Pengertian	Pelayanan pemasangan dan pelepasan implant adalah memasangkan dan pelepasan alat kontrasepsi bawah kulit (AKBK) berupa satu batang putih lentur panjang 40mm dan diameter 2mm yang berisi 68mg 3-keto-desogestrel, dengan lama kerja 3 tahun.	
Tujuan	Sebagai Acuan penerapan langkah-langkah pelayanan pemasangan dan pelepasan implant	
Kebijakan	1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.87 tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga,keluarga berencana dan sistem informasi keluarga 2. PERMENKES RI No. 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 3. PERMENKES RI No. 514 Tahun 2015 tentang managemen pelayanan KB	
Prosedur	PEMASANGAN : - Daerah tempat pemasangan implant ditutup dengan kain steril yang berlubang - Lakukan injeksi obat anastesi kira-kira 6-10cm diatas lipatan siku - Setelah itu dibuat insisi lebih kurang sepanjang 0,5cm dengan scalpel yang tajam - Troika dimasukkan melalui lubang insisi sehingga sampai pada jaringan bawah kulit - Kemudian kapsul dimasukkan kedalam troika dan didorong dengan plunger sampai kapsul terletak dibawah kulit - setelah kapsul berada dibawah kulit,troika ditarik pelan pelan keluar - Kontrol luka apakah ada perdarahan atau tidak - Jika tidak ada perdarahan tutup luka dengan kasa steril, kemudian diplester, umumnya tidak diperlukan jahitan - Nasehati pasien agar luka jangan basah selama lebih kurang 3 hari dan dating kembali jika ada keluhan-keluhan yang mengganggu - Pengangkatan atau ekstraksi - Teknik pengeluaran implant umumnya lebih sulit dari pada insersi. Persoalannya timbul apabila implant dipasang terlalu dalam atau jika timbul jaringan fibrous sekeliling implant Pengangkatan implant dilakukan atas indikasi sebagai berikut : - Atas permintaan pasien (seperti jika ingin hamil lagi) - Timbulnya efek samping yang sangat mengganggu dan tidak dapat diatasi dengan pengobatan biasa - Sudah habis masa pakainya - Terjadi kehamilan	

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PELAYANAN PEMASANGAN DAN PELEPASAN IMPLAN 2 BATANG		
	No.Dokumen 537.7/I-SPO/MTR/VI/2025	No. Revisi 02	Halaman 2 / 1

	PELEPASAN: 1. Alat-alat yang diperlukan selain dari alat-alat yang diperlukan sewaktu pemasangan kapsul implant diperlukam satu forceps lurus dan satu forceps bengkok 2. Tentukan letak posisi kapsul implant kalau perlu kapsul didorong kearah tempat insisi akan dilakukan 3. Daerah insisi didesinfeksi, kemudian ditutup dengan kain steril yang berlubang 4. Lakukan anastesi local, jangan menyuntikkan anastesi local diatas implat karena pembengkakan kulit dapat menghalangi pemandangan dari letak implantnya. Kemudian lakukan insisi selebar lebih kurang 5-7mm ditempat yang paling dekat dengan kapsul implant 5. Fosep dimasukkan melalui lubang insisi dan kapsul didorong dengan jari tangan kea rah ujung forceps 6. Forceps dibuka lalu kapsul djepit dengan ujung forceps 7. Kapsul yang sudah dijepit kemudian ditarik pelan-pelan 8. Kalau perlu dapat dibantu dengan mendorong kapsul dengan jari tangan lain. Ada kalanya kapsul sudah terbungkus dengan jaringan disekitarnya. Dalam hal ini lakukanlah insisi pada jarinagn yang membungkus kapsul tersebut pelan-pelan sampai kapsul menjadi bebas sehingga mudah menariknya keluar 9. Jika sewaktu mengeluarkan kapsul implant terjadi perdarahan, hentikanlah perdarahan terlebih dahulu dengan menekan daerah yang berdarah tersebut dengan kain kasa steril 10. Tutuplah luka insisi dengan kasa steril, kemudian di plester. Umumnya tidak diperlukan jahitan pada kulit,apabila akseptor ingin dipasang implant yang baru ini dapat segera dilakukan 11. Nasehati pasien agar luka tidak basah dan selalu dalam keadaan bersih selama lebih kurang 3 hari Sampai saat ini dikenal 4 cara pelepasan implant, yaitu sebagai berikut : 1. Cara POP-OUT. (Darmey, Klaise dan Walker) Merupakan teknis pilihan apabila memungkinkan karena tidak traumatis,sekalipun tidak selalu mudah untuk mengerjakannya. Dorong ujung proksimal “kapsul” (arah bahu) Kearah distal ibu jari sehingga mendekati lubang insisi, sementara jari telunjuk menahan bagian tengah “kapsul”, sehingga ujung distal “kapsul” menekan kulit. Bila perlu, bebaskan jaringan yang menyelubungi ujung ‘kapsul” dengan scalpel / bisturi. Tekan dengan lembut ujung kapsul melalui lubang insisi sehingga ujung tersebut akan menyembul / pop-out melalui lubang insisi. 2. Cara Standart : 2. Bila cara “POP-OUT” tidak berhasil atau tidak mungkin dikerjakan, maka dipakai cara standart. Jepit ujung distal “kapsul” dengan klem mosquito, sampai kira-kira 0,5-1cm dari ujung klemnya masuk dibawah kulit melalui
--	---

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PELAYANAN PEMASANGAN DAN PELEPASAN IMPLAN 2 BATANG		
	No.Dokumen 537.7/I-SPO/MTR/VI/2025	No. Revisi 02	Halaman 3 / 1
	lubang insisi. Putar pegangan klem pada posisi 180' disekitar sumbu utamanya mengarah kebahu akseptor. Bersihkan jaringan-jaringan yang menempel disekeliling klem dan "kapsul"dengan skalpet atau kasa steril sampai kapsul terlihat dengan jelas. Tangkap ujung kapsul yang sudah terlihat dengan ujung klem crile, lepaskan klem mosquito, dan keluarkan kapsul dengan klem crile. Cabut / keluarkan "kapsul-kapsul' lainnya dengan cara yang sama. 3. Cara "U" teknik ini dikembangkan oleh Dr. Untung Prawirohardjo dari Semarang. Dibuat insisi memanjang selebar 4mm, kira-kira 5mm proksimal dari ujung distal "kapsul". "kapsul' yang akan dicabut difiksasi dengan meletakkan jari telunjuk tangan kiri sejajar disamping "kapsul". Kapsul dipegang dengan klem atau forceps kurang lebu 5 menit dari ujung distalnya. Kemudian klem diputar kearah pangkal lengan atas/ bahu akseptor sehingga kapsul terlihat dibawah lubang insisi dan dapat di bersihkan dari jaringanjaringanyang menyelubunginya dengan memakai scalpel. Untuk seterusnya dicabut keluar. 4. Cara tusuk "Ma" dikembangkan oleh Dr. IBG Manuaba dari Denpasar memakai alat bantu kawat atau jari roda sepeda. Satu ujung dilengkungkan sepanjang 0,5-0,7cm dengan sudut 90' dan diperkecil serta diruncingkan. Sedangkan ujung yang lain dilengkungkan dalam satu bidang dengan lengkungan runcing tadi dan dipakai untuk pegangan operator. Setelah kapsul diklesm dengan klem arteri, jaringan ikat dibersihkan dengan pisau sampai kapsul tampak putih. Kemudian alat tusuk "M" ditusuk pada kapsul serta terus dikait keluar. Atau setelah kapsul dijepit dengan pinset klem arteri alat tusuk "Ma" ditusukkan kedalam kapsul sambil diungkit kearah luka insisi. Lalu piset atau klem aretri dilepaskan dan dengan pisau kapsul dibebaskan dari jaringan lain lalu diungkit keluar dari luka insisi.		
Unit Terkait	1. Poli Kandungan 2. Poli KIA		